

Nom :
Dossier CNESST :
Date de l'évènement :

A. RENSEIGNEMENTS SUR LE TRAVAILLEUR

Nom :
Prénom :
N° d'assurance maladie :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
No de dossier du travailleur :
Date de l'évènement d'origine :
Date de la récurrence, rechute ou aggravation : Nil

B. RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDECIN

Nom : CENTOMO
Prénom : Hugo
No permis : 1-18154
Adresse : 5777 Boul. Gouin Ouest, Suite 370, Montréal, Qc, H4J 1E3
Téléphone : 514-331-1400
Courriel : adjointe.orthopedie@gmail.com

C. RAPPORT

1. Mandat de l'évaluation

Le but de l'évaluation est de répondre aux points suivants de l'article de la LATMP :

- 1) Diagnostic.
- 2) Date de consolidation.
- 3) Nature, nécessité, suffisance, durée des soins ou traitements administrés ou prescrits.
- 4) a) Existence de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique.
b) Pourcentage de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique.
- 5) a) Existence de limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle.
b) Évaluation des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle.

Nom :

Dossier CNESST :

Date de l'évènement :

2. Diagnostics acceptés par la CNESST

3. Modalité de l'entrevue

4. Identification

Âge :

Dominance :

Emploi :

Activité de loisir :

Nom :

Dossier CNESST :

Date de l'évènement :

5. Antécédents

Médicaux :

Chirurgicaux :

Au site et au pourtour de la lésion :

Accidentels :

 CNESST :

 SAAQ :

 Autres :

Allergie :

Tabac :

Cannabis :

Alcool :

6. Médication actuelle et mesures thérapeutiques en cours

7. Historique de faits et évolution

Nom :

Dossier CNESST :

Date de l'évènement :

Nom :

Dossier CNESST :

Date de l'évènement :

8. Questionnaire subjectif et état actuel

Nom :
Dossier CNESST :
Date de l'évènement :

9. Examen Physique

Poids : kg Taille : m Dominance :

Observation générale et attitude :

Rachis Lombaire :

Palpation :

Inspection :

Amplitude articulaire :

	Patient (e)	Normale
Flexion		90°
Extension		30°
Flexion Latérale G.		30°
Flexion Latérale D.		30°
Rotation G.		30°
Rotation D.		30°

Nom :
Dossier CNESST :
Date de l'évènement :

Manœuvres radiculaires :

	Droit	Gauche
S.L.R.		
Tripode		
Lasègue		
Lasègue inversé (Ely)		

Hanches :

Palpation :

Inspection :

Amplitude articulaire :

	Droit		Gauche		Normale
	Actif	Passif	Actif	Passif	
Flexion		-		-	120°
Extension		-		-	30°
Rotation interne		-		-	40°
Rotation externe		-		-	50°
Abduction		-		-	40°
Adduction		-		-	20°

Manœuvres spécialisées :

	Droit	Gauche
Trendelenburg		
FADIR		
FABER		

Genoux :

Palpation :

Inspection :

Nom :
 Dossier CNESST :
 Date de l'évènement :

Amplitude articulaire :

	Droit		Gauche		Normale
	Actif	Passif	Actif	Passif	
Flexion		-		-	140°
Extension		-		-	0°
Varus/Valgus	Normoaxé		Normoaxé		-

Manœuvres ligamentaires :

	Droit	Gauche
LCI 0o		
LCI 20o		
LCE 0o		
LCE 20o		
Lachman		
Pivot		
Tiroir antérieur		
Tiroir postérieur		
Sag postérieur		
Dial à 30°		
Dial à 90°		

Manœuvres méniscales :

	Droit	Gauche
Apley		
McMurray		
Thessaly		

Atrophie musculaire :

	Droit	Gauche
Circonférence cuisse (cm)		
Circonférence mollet (cm)		

Pieds / Chevilles :

Palpation :

Nom :
Dossier CNESST :
Date de l'évènement :

Inspection :

Amplitude articulaire :

	Droit		Gauche		Normale
	Actif	Passif	Actif	Passif	
Dorsiflexion cheville					20°
Plantiflexion cheville					40°
Mvts sous-astragaliens					-
Mvts mid-tarsien					-

Manœuvres ligamentaires :

	Droit	Gauche
Tiroir 0°		
Tiroir 20°		
Varus stress		
Laxité calcanéo-péroné		

Manœuvres spécifiques tendons :

	Droit	Gauche
Single heel raise (Tib post)		
Thompson (Tendon d'Achille)		
Test d'appréhension (Fibulaires)		

Neuro-vasculaire :

Forces :

Racine (ASIA)	Droit	Gauche
L2 (flexion hanche)	/5	/5
L3 (extension genou)	/5	/5
L4 (dorsiflexion cheville)	/5	/5
L5 (extension D1 pied)	/5	/5
S1 (flexion plantaire cheville)	/5	/5

Nom :
Dossier CNESST :
Date de l'évènement :

Sensibilités :

Racine	Droit	Gauche
L2	/2	/2
L3	/2	/2
L4	/2	/2
L5	/2	/2
S1	/2	/2

Réflexes :

Réflexes	Droit	Gauche
Rotulien		
Achilléen		
Babinski		

Pouls :

	Droit	Gauche
Tibial postérieur		
Pédieux		

10. Examens paracliniques

Vous référez au point 7, Historique des faits et évolution.

11. Conclusion

Résumé :

Nom :

Dossier CNESST :

Date de l'évènement :

Diagnostic :

Date de consolidation :

Nom :

Dossier CNESST :

Date de l'évènement :

Nature, nécessité, suffisance, durée des soins ou traitements administrés ou prescrits :

Existence de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique :

Nom :

Dossier CNESST :

Date de l'évènement :

Existence de limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle :

Évaluation des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle :

Nom :
Dossier CNESST :
Date de l'évènement :

12. Pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique

1.	SÉQUELLES ACTUELLES		
	Code de séquelle	Description	%
	103 499	Atteintes des tissus mous avec séquelles fonctionnelles	2
	107 306	Ankylose incomplète perte de 10° de la tibio-tarsienne	2
2.	SÉQUELLES ANTÉRIEURES		
	Aucune		
3.	AUTRES DÉFICITS LIÉS À LA BILATÉRALITÉ		
	Ne s'applique pas		

NB : Nous n'avons pas attribué de pourcentage à l'asymétrie musculaire comme elle n'est pas mesurée à 15cm au-dessous du pôle inférieur de la rotule mais avons attribué l'atteinte des tissus mous.



Hugo Centomo, MD, PhD, FRCS ©
Chirurgien-orthopédiste